

Zamierające łóżko

Brak seksu w stabilnej parze (mniej niż 10× rocznie) jest częstym kontekstem PPU. Karta pokazuje, czy PPU jest tu przyczyną, skutkiem, czy oba.

CZAS: 45 min refleksja Dla par z deficytem seksu

ŹRÓDŁO: Donaghue (2015); Mark i wsp. (2020); Carvalheira (2014)

JAK UŻYWAĆ

„Zamierające łóżko” (ang. *dead bedroom*) — popularne określenie sytuacji, w której para w długotrwałej relacji ma **mniej niż 10 stosunków rocznie**. Karta przedstawia: 1) **jak** częste jest dead bedroom (badania populacyjne), 2) **związek** z PPU — przyczyna, skutek czy oba?, 3) **4 typy** dead bedroom z odpowiadającymi interwencjami, 4) krok pierwszy — rozmowa.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mark i wsp. (2020) w badaniu populacyjnym $n=2000$ par długoterminowych: **20-25% par** mieszka w stanie dead bedroom przez > 1 rok. Donaghue (2015): w 60% takich par jeden partner cierpi z powodu niedostatku, w 30% oboje, w 10% oboje zaakceptowali stan. Związek z PPU jest **dwukierunkowy**: 1) **PPU jako przyczyna** — pacjent z PPU obniża popęd do żywej partnerki, partnerka odsuwa się, łóżko zamiera; 2) **PPU jako skutek** — łóżko zamiera z innych powodów (stres, dzieci, konflikty, depresja), pacjent szuka ulgi w porno, co dodatkowo pogłębia problem. **Karta pomaga rozróżnić**, który scenariusz dotyczy Twojej pary — bo interwencja jest *różna*.

01 = Cztery typy dead bedroom + interwencje

TYP 1 · PPU JAKO PRZYCZYNA

Twój popęd „skierowany” w porno → brak energii / inicjatywy dla partnerki. Partnerka się odsuwa.

Interwencja: abstynencja od porno 6+ mies. → naturalny powrót popędu w parze.

TYP 2 · PPU JAKO SKUTEK

Łóżko zamarło z innych przyczyn (dzieci, depresja, konflikt) — Ty szukasz ulgi w porno. PPU jest *symptodem*.

Interwencja: terapia pary nad źródłem dead bedroom + Twoja praca nad PPU.

TYP 3 · MIESZANY (NAJCZĘSTSZY)

Oba mechanizmy działają — PPU zaczęło się jako symptom, ale obecnie też pogłębia problem. Spirala.

Interwencja: równoczesna praca nad PPU + terapia pary. Sekwencyjnie nie zadziała.

TYP 4 · NIEZALEŻNE

PPU istnieje, dead bedroom istnieje, ale jako *oddzielne* problemy (np. inny popęd partnerów, problem zdrowotny u partnerki).

Interwencja: dwa osobne tory pracy, koordynowane z terapeutą.

02 Jak rozpoznać swój typ

PYTANIE	TAK	NIE
Czy moja popęd seksualny obniżył się od początku PPU?		
Czy łóżko zamierało już przed nasileniem PPU?		
Czy partnerka odsuwała się, gdy odkryła PPU?		
Czy są inne źródła kryzysu w relacji (dzieci, finanse, choroba)?		

03 ● Pierwszy krok — uczciwa rozmowa

Dead bedroom najczęściej trwa, bo o nim *nikt nie mówi*. Każdy partner zakłada, że drugi jest „w porządku” lub nie chce ranić. Pierwszy krok: **nazwać**.

CO POWIEDZIEĆ

„Widzę, że nie uprawiamy seksu od X miesięcy.
Tęsknię za intymnością z Tobą. Chciałbym o tym z
Tobą porozmawiać — z ciekawością, nie obwiniając.”

Bez presji, bez obwiniania, z otwartością.

CZEGO NIE MÓWIĆ

„Czemu nie chcesz seksu?” — obwinia.
„Inne kobiety chętnie by chciały” — szantaż.
„Może gdybyś...” — krytyka.
„Czuję, że już mnie nie kochasz” — manipulacja.

Zacznij od *swoich* uczuć i potrzeb, nie ocen partnerki.

04 Mit i fakt o seksie w długiej relacji

Mit: w zdrowej relacji popęd jest *spontaniczny*.
Fakt: Basson (2000) — u większości osób w długiej relacji popęd jest *responsywny* (pojawia się *po* dotyku, atmosferze), nie spontaniczny.

Mit: gdy popęd opada, to *koniec miłości*.
Fakt: popęd biologiczny normalnie opada po 18–36 mies. Intymność (oksytocyna) zastępuje pożądanie (dopamina) — to *dojrzewanie* relacji, nie jej koniec.

Mit: jeśli musimy *planować* seks, to znaczy że relacja jest zła.

Fakt: pary w długich relacjach *zwykle* potrzebują planowania. Bez tego — seksu po prostu nie ma czasu.

Mit: dobry seks = częsty seks.
Fakt: jakość > ilość. 1x w miesiącu pełnego, intymnego seksu jest lepsze niż 4x szybkiego, mechanicznego.

Klucz: Carvalheira (2014, n=550 par długoterminowych) wykazała, że **satysfakcja z relacji** jest *silniejszym predyktorem* seksu w parze niż popęd biologiczny. Pary, które dobrze się dogadują emocjonalnie, mają **3x częściej** seks niż pary z równą biologią, ale rozproszoną komunikacją. *Praktyczna konsekwencja:* jeśli pracujesz nad relacją (komunikacja, czas razem, czuły dotyk, terapia pary), seks *zwykle wraca sam*. Jeśli pracujesz tylko nad seksem (techniki, częstotliwość) bez relacji — niewiele osiągniesz. Dead bedroom rzadko jest problemem seksualnym — najczęściej jest problemem relacyjnym, którego seks jest *objawem*.